

Agente de Energía (Vitality & Burnout)

1. Justificación Neuroclínica y Arquitectura del Agente

El **Agente de Energía y Vitalidad** examina el estado energético global del individuo desde una perspectiva holística, diferenciando la fatiga neuromuscular de la astenia psíquica o agotamiento central. Un consumo desmedido de redes sociales genera **Agotamiento del Ego (Ego Depletion)** y desregulación dopaminérgica.

Dado que la fuerza de voluntad y la autorregulación cognitiva comparten un fondo común limitado de recursos metabólicos cerebrales, la sobreexposición a estímulos estresantes o hiperestimulantes agota las reservas de energía, provocando apatía, abulia y anhedonia inducida (un estado donde nada fuera del mundo virtual genera suficiente estímulo hedónico debido a la desensibilización de los receptores dopaminérgicos).

INTEGRACIÓN HOLÍSTICA DEL AGENTE

Este módulo es sumamente sensible: recopila fluctuaciones de energía en tres picos hormonales clave del cortisol (08:00 AM, 02:00 PM y 08:00 PM), evaluando la presencia de cansancio crónico, inercia del sueño (embotamiento al despertar) y sedentarismo correlacionado con el uso abusivo del dispositivo.

2. Protocolo de Diagnóstico y Variables Operacionales

El agente se basará en subescalas del Inventario de Burnout de Maslach (MBI) y la Escala de Fatiga de Chalder (CFS):

- **Agotamiento Emocional:** Sensación de estar exhausto debido a la sobrecarga de interacciones digitales o demandas del entorno.
- **Fatiga Mental / Central:** Disminución de la fuerza motivacional para iniciar conductas saludables (ejercicio, socialización en persona).
- **Inercia del Sueño Prolongada:** Persistencia de cansancio psicofísico más de 60 minutos después de la vigilia, indicativo de un ritmo circadiano desalineado.

NIVEL DE ENERGÍA	INDICADOR PSICOFISIOLÓGICO	ACCIÓN DIAGNÓSTICA DE LA IA
Óptimo (Homeostasis)	Curva de cortisol normalizada, vitalidad matutina	Mantenimiento preventivo, incentivar picos de productividad.
Fatiga Aguda Compensada	Cansancio reactivo vespertino, necesidad de estimulantes	Recomendar descansos de recarga dopaminérgica limpia (caminata analógica, hidratación).
Agotamiento Crónico / Burnout	Anhedonia, astenia generalizada, desmotivación estructural	Alerta roja: Intervención restrictiva de pantallas. Sugerir un "Ayuno de Dopamina" digital supervisado.

3. Reglas de Progreso Diario y Disparadores Clínicos

El progreso se evalúa mapeando la curva de recuperación energética: un usuario saludable muestra mayor vitalidad matutina si el Agente de Sueño reportó alta eficiencia. Si la energía se mantiene en niveles críticos (**E $\leq$ 3/10** en escala Likert) de forma persistente, el agente emite un diagnóstico clínico de sospecha de burnout o episodio depresivo subclínico, sugiriendo la derivación a un profesional de la salud humana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CLÍNICAS Y CERTIFICADAS

1. **Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P.** (1996). *Maslach Burnout Inventory Manual*. 3rd Edition. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
2. **Chalder, T., Berelowitz, G., Pawlikowska, T., et al.** (1993). *Development of a fatigue scale*. Journal of Psychosomatic Research, 37(2), 147-153. [Escala médica estandarizada para medir fatiga física y mental].
3. **Sapolsky, R. M.** (2004). *Why Zebras Don't Get Ulcers*. 3rd Edition. New York: Henry Holt and Co. [Texto fundamental sobre el estrés crónico, eje HPA, cortisol y el agotamiento de las reservas de energía del organismo].
4. **Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Muraven, M., & Tice, D. M.** (1998). *Ego depletion: Is the active self a limited resource?* Journal of Personality and Social Psychology, 74(5), 1252-1265.